

37 - 02- Fièvres éruptives de l'enfant - Pr. Bouskraoui

Chers étudiants, chères étudiantes, nous allons aborder aujourd'hui un cours très intéressant en pédiatrie, il s'intitule « Les fièvres éruptives de l'enfant ». C'est une situation fréquente en pratique pédiatrique courante et nécessite une analyse clinique précise. Lorsque le diagnostic est fait, il faut non seulement évaluer la gravité pour le patient et adapter la prise en charge, mais aussi les éventuels risques pour l'entourage qui peuvent nécessiter une prise en charge spécifique. Pour aborder notre cours sur les fièvres éruptives de l'enfant, nous vous exposons sur cette slide les objectifs pédagogiques terminaux et les objectifs pédagogiques intermédiaires pour chaque pathologie.

L'examen clinique doit permettre d'orienter le diagnostic étiologique d'une éruption cutanée. Dans un contexte de fièvre, cinq étapes vont guider cette démarche. L'étape 1, c'est l'analyse des lésions cutanées élémentaires.

L'étape 2, c'est l'analyse de la topographie et de mode d'extension des lésions cutanées. L'étape 3, c'est la recherche de signes associés. L'étape 4, c'est la recherche de données contextuelles qui peuvent avoir un intérêt diagnostique.

Et enfin, la dernière étape, qui est l'étape 5, à l'issue des étapes précédentes, il est habituellement possible de rattacher l'ensemble de tableaux cliniques observés à une maladie connue. Abordons donc la première étape, qui est l'analyse des lésions cutanées élémentaires. La visicule est une collection cutanée liquidienne à contenu clair.

Son aspect initial est classiquement celui d'une goutte de rosée posée sur une base érythémateuse sur une possène. Son diamètre ne dépasse pas 2 mm, son contenu se trouble et sa surface se flétrit et finalement place à une croûte jaune ou noire à hâte qui disparaît sans laisser de cicatrices, ce n'est pas gratté. Alors la bulle est de diamètre supérieur à 5 mm et correspond à un solivement épidermique, lui-même dû à la présence d'une collection liquidienne intraépidermique.

La bulle est fragile, souvent remplacée par une croûte après sa rupture, avec un signe de Nékolsky positif, c'est-à-dire une séparation des cellules épidermiques provoquées par un frottement appuyé en zone cutanée indemne ou sous l'épiderme. Ce sont alors des bulles plus robustes, donc plus souvent intactes, avec un signe de Nékolsky négatif. Enfin, des bulles situées au centre d'une lésion cocarde sont caractéristiques de l'érythème polymarqué qu'on verra par la suite.

L'érythème s'efface à la vitre pression et il peut être localisé au défu, palpable donc papuleux, au non palpable et donc maculeux. Pour l'étape 2, qui est l'analyse de la topographie et de mode d'extension des lésions cutanées, il faut savoir que certaines éruptions respectent le tronc, comme en haut et à gauche le syndrome du géonotique crusty, en haut et à droite le syndrome

main-pied-bouche, et puis on peut avoir en bas et à droite ce qu'on appelle un syndrome papuleux-purpurique en gants et en chaussettes. Ou bien, parfois, les lésions peuvent prédominer sur une partie du tronc, comme en bas en milieu l'exantème unilatéral latérothoracique.

Enfin, l'éruption peut apparaître sans ordre ou présenter une évolution caractéristique, comme pour la rougeole, en bas et à gauche, la marche descendante de la rougeole, où l'éruption débute à la limite du cuir chevelu, derrière les oreilles et le front. La troisième étape est une étape très intéressante, puisqu'elle va chercher des signes associés qui peuvent avoir une orientation diagnostique. Par exemple, l'importance et la durée de la fièvre sont des éléments déterminants de diagnostic de certaines maladies.

Une fièvre élevée, par exemple, peut s'observer dans la rougeole, la scarlatine et la maladie de Kawasaki. La survenue d'une desquamation, en doigt de gant ou en lambeau des cours de l'éruption, peut s'observer dans la maladie de Kawasaki et la scarlatine. Le prairie, comme vous le savez, est un signe très important de la varicelle.

Lorsqu'il est associé à de l'irritum, il peut évoquer une réaction cutanée à un médicament. L'examen de la cavité buccale à la recherche d'un néonème est un temps important, étape importante aussi, avec la recherche de fameux signes copiques de la rougeole, l'angine de la scarlatine, l'angine à fausse membrane de la mononucléose infectieuse, et puis la recherche de la langue framboisée qui peut se voir aussi dans la scarlatine et la maladie de Kawasaki. Enfin, la recherche d'adénopathie, que ce soit au céphalique de la rubiole, au cervical de Kawasaki et de la mononucléose infectieuse, et de la splénomégalie au cours de la mononucléose infectieuse, est une étape aussi importante et systématique.

Des données contextuelles peuvent avoir un intérêt diagnostique. Retour d'un pays étranger ou tropical, un traitement court chronique ou récent, des vaccinations réalisées, l'âge de l'enfant, et enfin une maladie chronique connue. Enfin, l'anamnèse et l'examen clinique de l'enfant doivent être précis et complets.

Toujours examiner un enfant tenu. Des situations cliniques envisageables dans le contexte d'urgence. Regardez sur cet algorithme.

Par exemple, la situation clinique 1 où vous avez un purpura. C'est l'extrême urgence. Il y a la deuxième situation clinique où l'éruption cutanée peut orienter vers un diagnostic étiologique dont la signification pronostique est péjorative, comme la maladie de Kawasaki ou la staphylococci.

Et puis la situation clinique 3, là où vous avez par exemple la scarlatine, l'éruption cutanée peut orienter vers une maladie pour laquelle existe un traitement spécifique, mais dont l'urgence n'est pas immédiate. Enfin, une situation plus prêtée, c'est là où il y a une éruption cutanée et qui oriente vers une maladie infectieuse connue, sans traitement spécifique, et dont le pronostic est habituellement bénin. Le purpura est une tâche rouge due à l'éruption des globules rouges hors

des vaisseaux.

C'est une extravasation. Il va se différencier facilement de l'uritem car il ne s'efface pas à la vitre pression. Il peut être équimotique et nécrotique, comme vous le constatez sur cette photo, ou rapidement extensif.

Lorsqu'il est extensif, il signifie un purpura fulminans. Et tout purpura fibril doit être considéré comme une infection améningocoque jusqu'à preuve du contraire. Le purpura fulminans est d'une extrême gravité.

D'autres agents infectieux, et en particulier les antivirus, peuvent donner un purpura. Le purpura des maladies infectieuses peut résulter d'un effet direct ou indirect, c'est-à-dire immunologique, de l'agent infectieux sur la paroi vasculaire, ou le résultat d'une thrombopénie. Nous allons voir ensemble des exemples d'uritem, soit localisés, soit dérus.

Et avant de le faire, nous allons vous exposer un petit rappel sémiologique sur les exantèmes. Rappelez-vous que l'uritem se définit comme une rougeur congestive de la peau, sans infiltration palpable et disparaissant à la pression. L'uritem peut être maculeux avec de petites taches rosées ou rouges sans relief ni infiltration papuleuse, c'est-à-dire les lésions surélevées, d'aspect voluté souvent associé au précédent.

Et donc là va être de l'éruption maculeux-papuleuse dérus en nappe ou en placard. L'éruption scarlatiniforme, qu'il faut toujours opposer à l'éruption morbidiforme. En fait, l'éruption scarlatiniforme, c'est de vastes nappes rouges vifs uniformes parsemées d'un piqueté maculeux-papuleux qui donne au toucher une sensation de peu gruneux, sans intervalle de possède.

Au sein des plaques, sur ton regard dépli, il peut exister un piqueté pulpulique, comme vous le constatez à droite. L'érythème morbidiforme, ce sont des macules lenticulaires rosées ou rouges, planes ou très légèrement saillantes, ces éléments conflits pour endroits pour former de petites nappes de taille inégale, à contours irréguliers et séparées par des intervalles de possède, comme vous le constatez à gauche. Et nous allons commencer par une maladie que vous connaissez très bien, c'est la rougeole.

Dans la rougeole, l'invasion va durer trois à cinq jours et, marquée par un cathare oculorespiratoire, l'éruption est maculeux-papuleuse, non prorogineuse. Il va débuter dans la seine rétro-auriculaire, derrière les oreilles, puis s'étend sur tout le corps, il va descendre. Sa durée est de cinq à sept jours, et il est suivi d'une fine disquamation peu visible.

Il est accompagné d'un anathème, ces classiques signes de coplique fugaces et difficiles à voir. Dès la phase d'invasion de l'enfant, qui est très fibrile, asténique, la fièvre peut persister après l'apparition de l'éruption. L'association d'une fièvre, d'une éruption maculeux-papuleuse, et de moins un des signes suivants, doit évoquer le diagnostic de la rougeole, c'est-à-dire la conjonctivite, la toux, le choréza, le signe de coplique.

La contagiosité forte par voie aérienne commence avec l'invasion et persiste jusqu'au cinquième jour de l'éruption. Dans la rubiole, l'incubation est d'environ 2 à 3 semaines. L'invasion est discrète, à peine cataracte.

L'exanthème est un hérietier maculeux qui débute sur la face et est plus discret sur le corps avec un aspect en nappe au niveau des plaies de flexion. La fièvre est modérée autour de 38 degrés Celsius et il y a peu ou pas d'anthème. Des adénopathies cervico-occipitales assez volumineuses accompagnent l'éruption et l'éruption peut disparaître en 3 à 5 jours.

Il faut noter que la plupart des rubioles peuvent passer inapparentes. La scarlatine est une infection bactérienne du streptobéta-hémolytique de groupe A et les signes spécifiques de la scarlatine sont dus à la sécrétion d'une toxine érythrogène par le streptocoque. Dans la scarlatine, l'éruption est congestive en nappe sans intervalle de peau saine associée à de petites papules plus sombres qui donnent au toucher un aspect granité à la peau.

L'éruption débute au niveau du tronc, souvent sur le siège et va s'étendre en périphérie. Elle prédomine au grand pli de flexion des membres comme vous le constatez sur la photo et elle peut prendre un aspect pulpulique linéaire comme signe de pastilla. Lorsqu'il atteint la face, elle respecte les ailes de nez et le pourtour de la bouche, le sillon nasogénien, en marquant nettement la limite.

D'autres signes cliniques de grande valeur diagnostique sont caractéristiques de la scarlatine. La glucite exfoliatrice et la disquamation Dans la glucite exfoliatrice, la langue est initialement recouverte d'un enduit blanchard qui disparaît de la pointe et déborde vers la base, dessinant un point antérieur. La langue prend alors un aspect framboisé dû à l'hypertrophie des papilles linguales qui prédomine au septième jour d'évolution.

Enfin, la disquamation va débiter vers le septième jour d'évolution, là où l'éruption a débuté, et se termine en main et au pied où il va prendre un aspect classique en lambeau. Il peut durer plusieurs semaines. La rosiole, ou l'exantème, subit, aux sixièmes maladies, une maladie bénigne liée au virus HHV-6, c'est un virus de la famille de l'herpès.

La maladie va toucher surtout les nourrissons de 6 mois à 24 mois et l'incubation va durer d'une dizaine de jours à deux semaines, sans signe particulier. La maladie va débiter par une fièvre très élevée, accompagnée d'une petite diarrhée, classiquement pendant 48 heures. L'éruption va apparaître au troisième jour, regardez sur le graphique, et dans le même temps où la fièvre disparaît, c'est-à-dire apérexie, et l'éruption va apparaître.

Elle est constituée d'humacules rosés, prédominants sur le tronc, qui vont disparaître en 48 heures sans aucune désquamation. Les complications sont rares et il a été remarqué quelques convulsions fibriles. Le mégalerithème épidémique est une infection vérale qui est due au parvovirus B19 qui se réplique uniquement dans les précurseurs des éreutricites humaines.

L'infection va s'accompagner du signe généraux très modéré, une fièvre inconstante, mais d'un exanthème évocateur. Le visage est le siège d'un érythème intense, accompagné d'une pâleur circumorale. L'exanthème symétrique va débiter au niveau du tronc et s'étend de façon centrifuge au niveau des membres.

Il est fait de grandes macules, plus ou moins confluentes, qui s'éclaircissent par leur centre, ce qui confère à l'éruption un aspect typique en Guirlande. Le prurice est fréquent et l'éruption est fluctuante dans son intensité et récidive avec des modifications de l'environnement comme la chaleur et l'exposition solaire durant plusieurs semaines. Les éléments du diagnostic clé sont donc l'âge, en général ça survient chez un enfant entre 5 et 10 ans, la notion d'épidémie familiale au scolaire, des signes négatifs, en général il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'atteinte de l'état général, et l'éruption est caractéristique.

Et puis enfin, cette éruption, cet irritant bilatéral et symétrique des joues, qui paraissent comme souffler, devrait vraiment évoquer le diagnostic. La maladie de Kawasaki est un syndrome adéno-cutané que, comme vous le savez, il est d'étiopathogénie, est toujours inconnu, on a craigné beaucoup de choses. La fièvre est constante, élevée, et qui va se prolonger.

L'exanthème et les héritiers maculeux papuleux, sans vraies caractéristiques spécifiques, la localisation périnéale est sans aucun doute le caractère le plus particulier, avec l'atteinte des faces d'extension des bras et des jambes. La modification des extrémités fait partie aussi de l'éruption. Érythème palmoplantaire, œdème des mains et des pieds, et surtout, comme vous le constatez sur l'iconographie, des squames importantes assez spécifiques, mais malheureusement tardives.

La conjonctivite est précoce, mais en général c'est une conjonctivite qui est intense avec hyperémie, mais sans sécrétion. La kératite est en règle intense et évocatrice. Les adénopathies sont de localisation cervicale, parfois volumineuse, peuvent simuler un hémolyse flégment, et le diagnostic doit être évoqué devant toute association d'une fièvre importante, d'une éruption atypique et d'une altération de l'état général toujours présente dans la maladie de Kawasaki.

L'atteinte de la constitution du tableau typique, avec un certain nombre de critères, est requis. Cependant, le Kawasaki du nourissant est souvent incomplet et atypique. Il faut noter que dans la maladie de Kawasaki, vous avez un syndrome inflammatoire très important avec une CRP constamment très élevée.

La fièvre botanose méditerranéenne est due à Rickettsia, transmise par l'écaille du chien. C'est une éruption maculopapuleuse qui est associée à une fièvre élevée. Regardez l'iconographie en bas et à droite, elle montre cette tache noire qui est la porte d'entrée de la bactérie et qui permet d'évoquer le diagnostic.

C'est une maladie qui est endémique sur tout le pourtour méditerranéen. L'érythème migrant est la manifestation cutanée précoce de maladies de la haine et se caractérise par des plaques

annulaires érythémateuses, souvent avec une papule érythémateuse centrale au site de la tique. Les éléments diagnostiques clés sont la notion de pécure du tic dans le jour ou semaine précédent mais qui est inconstante, l'érythème annulaire, unique le plus souvent, centrée sur le point de la pécure, qui indolore et qui va s'élargir de façon centrifuge progressivement sur plusieurs jours.

La crotte d'ermite papuleuse est probablement d'origine virale et décrite par Gianotti Crosti. L'éruption va apparaître de manière brutale sans prodrome. Il est constitué de papules érythémateuses monomorphe, bilatérales et symétriques recouvrant la face, les membres et respectent la zone médio-faciale.

Il n'y a pas de prurie et l'éruption peut évoluer par poussée sur 2-6 semaines. La fièvre est modérée autour de 38°C, il n'y a pas d'anthème et les signes d'accompagnement sont inconstants, arthralgie, splénomégalie, adénopathie. L'Epstein-Barr virus est l'agent étiologique de la mononucléose infectieuse.

La primo-infection chez les jeunes enfants est habituellement asymptomatique ou s'accompagne de manifestations peu spécifiques comme une infection des voies aériennes supérieures, une pharyngite, une fièvre prolongée avec le sang, polyadénopathie. Parfois, chez les jeunes enfants ou plus souvent chez les adolescents, la mononucléose infectieuse se traduit plus typiquement par l'association d'une fièvre, d'une asthinie, d'une angine à fausse membrane, de dents palpébrales, de polyadénopathie prédominant sur le chène ganglionnaire cervicale et d'une hypothèse splénomégalie. L'exantème inconstant est plus fréquent chez les jeunes enfants.

La forte corrélation observée chez l'adolescent entre l'administration d'ampicillines et l'apparition d'une éruption maculopapuleuse n'est pas aussi nette chez l'enfant. L'éruption est du type morbidifar débutée entre le quatrième et sixième jour d'évolution et siège principalement sur le tronc et les membres supérieurs. Après les éruptions érythémateuses, nous allons voir donc un certain nombre d'exemples d'éruptions visiculeuses.

La varicelle est due au virus varicelle zona, qui est un membre de la famille des herpès virus. L'éruption visiculeuse associée à du prurit très intense, une fièvre modérée et des signes généraux. La visicule, la lésion fondamentale évolue à plusieurs stades visicule, pustule, ombilication, formation d'une croûte qui tombe sans laisser de cicatrice vers le septième jour d'évolution.

4 à 5 poussées de visicules espacées d'une douzaine d'heures sont observées, ce qui fait que coexistent des éléments d'âge différents. Les visicules, en nombre variable, en général en moyenne 250 à 500, sont disséminées et des localisations meucles sont possibles. Les complications qui peuvent se voir au cours d'une varicelle sont la surinfection bactérienne cutanée estrepto-astaphe, une thrombopénie, une arthrite, une hépatite, une ataxie cérébelleuse, une encéphalite, une méningite, une glomeruline éphrite et on peut avoir ce qu'on appelle un

syndrome de Reye favorisé par la prise d'aspirine au cours d'une varicelle.

A noter que chez l'enfant immunodéprimé, la varicelle peut être grave avec une éruption qui va se prolonger, une fièvre très élevée et possibilité du développement d'une encéphalite, d'une pneumonie ou d'une hépatite. Et l'éruption revêt sur ce terrain souvent un caractère hémorragique. La gingivostomatite herpétique survient chez l'enfant à partir de l'âge de 6 mois.

Il s'agit d'une gingivostomatite vésiculeuse très douloureuse entraînant une aphagie et une hypersialorée qui peut précéder de quelques jours l'éruption. Nous pouvons observer parfois des lésions vésiculeuses péribuccales, l'état général est altéré et la fièvre est élevée. Le traitement va alors reposer avant tout sur des mesures symptomatiques comme l'hydratation, la nutrition, les antalgiques, l'utilisation d'anesthésiques de contact et discuter.

Les bains de bouche sont de réalisation difficile chez le petit enfant et l'administration d'aciclovir est recommandée. La surinfection herpétique d'un enfant atteint de dermatite atopique au syndrome de Kaposi, jeunesse belge, est potentiellement grave et doit être repérée très rapidement. C'est une éruption faite de vésicules, parfois hémorragiques, rapidement rompues, laissant place à des érosions, à contours polycycliques puis à des croûtes.

L'éruption va toucher souvent le visage et peut s'étendre rapidement au reste du corps. La fièvre est élevée et l'état général de l'enfant est altéré. Ce tableau est souvent diagnostiqué comme une surinfection bactérienne ou comme une aggravation de la dermatite atopique.

Le traitement va reposer sur l'administration de l'aciclovir par voie intraveineuse. Le contact est souvent dû à un adulte ayant une récurrence herpétique labiale. Regardez comment les vésicules prédominent au niveau des extrémités.

C'est ce qu'on appelle un syndrome main-pied-bouche. Une entité à part, c'est l'érythème noueux avec ses nodules dermoépidermiques en regard du tibia. Enfin, nous allons aborder les éruptions bulleuses.

Et commençons par une infection fréquente, l'impétigo, que vous avez sûrement rencontré au cours de votre stage hospitalier. Les éléments clés orientant vers l'impétigo, c'est l'âge, c'est fréquent chez les petits, des vésicules ou des bulles près d'une lésion primitive ou parfois des lésions secondaires plus erratiques. Au niveau des régions accessibles au niveau du grattage, le ventre, le visage, les membres, il peut avoir un aspect vésiculeux bulleux comme à droite. C'est ce qu'on appelle un impétigo staphylococcique.

Mais on peut avoir aussi un aspect creux et mélicérisé qui va orienter vers l'origine streptococcique. L'écrymose staphylococcique aiguë est une infection potentiellement grave touchant le plus souvent l'enfant de moins de 5 ans. Elle est due à certains staphylococcus aureus qui produisent des toxines exfoliantes responsables d'un décollement interkératinocitaire.

Le début est souvent brutal associant une altération de l'état général avec fièvre, une éruption scarlatiniforme c'est-à-dire sans intervalle de possènes qui va débiter au niveau des plis, au niveau des régions périorificielles et en 24-48 heures vont apparaître des bulles flasques aux ondes de frottement avec un signe nékolskiopocène, un érythème, des croûtes et des fessures périvocales sont souvent observées. Il n'y a pas de trouble hémodynamique pour que vous puissiez le différencier de tableaux de chocs toxiques staphylococciques. Le foyer infectieux initial est cutané, ça peut être un ampélite gout orificiel, une ampétitisation d'une varicelle ou une onphalite, ou plus rarement extra-cutané, une forme clinique mineure sans décollement cutané mais avec présence de signes meuqueux et décrites sous l'appellation de scarlatine staphylococcique.

Les chocs toxiques streptococciques et staphylococciques sont secondaires à la sécrétion de toxines secrétées à partir d'un foyer bactérien. Les éléments diagnostiques clés sont une éruption scarlatineforme et l'association à des signes généraux sévères de type toxinique comme une fièvre élevée, choc, diarrhée, vomissement, déshydratation, insuffisance cardiaque, hépatique Les héritains polymorphes peuvent être diagnostiqués sur les éléments suivants. L'aspect typique des lésions.

Il s'agit de lésions maculopapuleus ovales plus ou moins confluentes et souvent symétriques. Elles sont fixes, à la différence de leur ticker, et évoluent en 2 à 3 jours vers un aspect caractéristique en coca, c'est-à-dire concentrique avec un halo périphérique comme vous le constatez au niveau de ce slide, un halo périphérique eudémacié et sombre, une large zone centrale claire elle-même centrée par une petite lésion plus sombre ou bulleuse. Cette lésion cutanée caractéristique, c'est la cocarte.

Les lésions meuqueuses sont possibles et puis la présence d'une atteinte meuqueuse, d'un décollement cutané, d'une fièvre élevée doit faire suspecter une toxidermie grave et interrompre les médicaments suspects. L'héritage polymorphe est une infection bénigne survenant le plus souvent quelques jours après une récurrence herpétique ou une infection bénigne à mécoplasme. Le syndrome de Steven Jensen et la syndrome de Lyell sont des infections graves et rares.

Il existe souvent des prodromes à type de toux, douleurs pharyngées, conjonctivites. Les signes généraux sont fréquents avec fièvre, altération de l'état général. Les lésions cutanées sont des macules papules, parfois perpuriques, qui se regroupent entre elles pour former des nappes dans les moules.

La surface va secondairement se décoller. La proportion de surface cutanée décollée définit le syndrome de Steven Jensen, moins de 10% de la surface corporelle, ou le syndrome de Lyell, plus de 30% de la surface corporelle. Le tableau clinique se complète souvent en plusieurs jours.

L'atteinte muqueuse est volontiers précoce et se manifeste par des érosions douloureuses des

muqueuses buccales, génitales et oculaires. L'infection ampicplasme est principalement responsable d'un héritage polymorphe majeur et de syndrome de Stevens-Johnson. Les médicaments sont responsables de syndrome de Stevens-Johnson de l'aïllée.

L'urticaire aiguë fréquente chez l'enfant. La moitié des urticaires aigus de l'enfant vus dans un service d'urgence sont accompagnés de la fièvre. Les deux causes les plus fréquentes sont les infections vérales et les prises des médicaments.

L'urticaire aiguë est une éruption érythémateuse, souvent palpable, avec des papules. Les lésions cutanées sont fugaces et migratrices. C'est un élément de l'interrogatoire très important.

Le pruré est fréquent chez le grand-enfant, mais souvent absent chez les nourissants. Et pour terminer, les toxidermies peuvent réaliser tous les types d'éruptions fibriles chez l'enfant. La forme la plus fréquente est l'éruption maculopapuleuse érythémateuse, avec un rash maculopapuleux, qui va survenir 7 à 10 jours après le début de la prise médicamenteuse.

Le diagnostic de toxidermie est souvent difficile dans ce cas chez l'enfant, car bien souvent en cause un antibiotique, un ANS, qui a été prescrit en raison d'un syndrome fibrile potentiellement d'origine vérale, ce qui peut lui aussi être responsable d'une éruption maculopapuleuse. Le diagnostic est essentiellement clinique. En conclusion, le diagnostic étiologique des éruptions fibriles de l'enfant impose une démarche qui doit en premier reconnaître et donc évoquer les diagnostics urgents, et en premier le purpura ménagococcyque en particulier, et ensuite faire une analyse sémiologique pour se diriger dans la langue lisse des autres causes.

La démarche est traditionnellement dominée par le diagnostic des maladies vérales de l'enfant. Certaines maladies sont souvent bénignes pour l'enfant, mais graves dans certaines situations d'immunodépression. Il y a toujours des nouveautés dans les éruptions fibriles de l'enfant.

La rougeole, les toxidermies, la place des parvovirus, on sent des exemples. La prévention par la vaccination est une réalité pour certaines maladies, un espoir pour d'autres, varicelles, ménagococcyques, etc. Au total, la prise en charge des éruptions fibriles peut paraître paradoxale entre les gravités extrêmes et la bénignité, entre l'absence presque en sens de complication et les redoutables conséquences sur certains terrains, entre l'inefficacité des traitements antiviraux et la réussite des campagnes de prévention vaccinale.